

速尿注射液与氨基糖甙类抗生素的配伍稳定性

临床上常将速尿注射液与氨基糖甙类抗生素配合应用,治疗某些严重的病例,尽管两类药物伍用存在加重肾毒性的可能性。作者将速尿注射液经过三叉管加到含硫酸庆大霉素的5%葡萄糖注射液中,发现有乳白色沉淀。为进一步了解速尿注射液与氨基糖甙类抗生素混合后理化性质的变化,为临床应用提供有价值的资料。作者以肉眼及显微镜观察沉淀,检测pH变化、使沉淀溶解和提纯,鉴定沉淀物,以评价速尿注射液与五种常用的氨基糖甙类抗生素(硫酸庆大霉素1.6mg/ml、硫酸卡那霉素2mg/ml、硫酸丁胺卡那霉素2mg/ml、硫酸乙基紫苏霉素1.5mg/ml、硫酸妥布霉素1.6mg/ml)的配伍。

在适量5%葡萄糖和0.9%氯化钠注射液中,按临床使用剂量配制含上述五种抗生素的溶液,当将速尿注射液(4ml:40mg)分别加到上述溶液中后,含硫酸庆大霉素和硫酸乙基紫苏霉素的溶液产生白色沉淀,含另外三种氨基糖甙类抗生素的溶液,出现混浊,但振荡后即澄清。

鉴于临床常将速尿注射液经输液器三叉接管处注射给药,以速尿注射液分别与含五种氨基糖甙类抗生素溶液等体积(1:1)混合的实验中得到了与上述相同的结果。

已知速尿注射液在低于pH值5.5的环境中易析出沉淀,上述配制含庆大霉素和乙基紫苏霉素溶液pH约4左右,加入速尿注射液后pH值平均上升约0.5。滴加1N氢氧化钠液使沉淀溶解的pH值约为5.9。

从速尿注射液与庆大霉素混合液中分离纯化得到的沉淀物,经熔点测定和光谱分析证实是速尿。

作者建议速尿注射液应单独给药,或者先停止注射含有氨基糖甙类抗生素的输液,然后经由三叉管注入速尿注射液,但在注射速尿前后,应用5%葡萄糖和0.9%氯化钠注射液冲洗输液管道,以避免速尿注射液与含这类药物,尤其是含庆大霉素和乙基紫苏霉素的输液接触。

[Amer J Hosp pharm 1985; 42(1):116]

(顾振平摘译 阎政校)

中国医院药学杂志1986年第6卷第7期

甲氟咪胍的药物相互作用

多数患者短期或长期接受甲氟咪胍治疗,它和其他药物合并使用的可能性极高。据1981年10月至1982年3月的调查, β -阻断剂和镇痛剂有1~2%与甲氟咪胍合并使用,这仅是同一处方中合并用药情况,其他合并用药可能更多。

甲氟咪胍对其他药物吸收的影响较小,但可强烈地抑制某些药物的代谢,特别是与治疗范围比较狭窄,主要是通过氧化代谢而消除的药物合并使用时,发生相互作用。

和甲氟咪胍发生相互作用的药物

A. 甲氟咪胍抑制代谢的药物

茶碱

心血管药:柳胺苄心定、心得安、利多卡因

抗凝剂:华法令

精神药物:利眠宁、安定、氟甲噻嗪

抗癫痫药:苯妥英钠、氨甲酰苯唑

镇痛药:美散痛、吗啡

B. 减少甲氟咪胍吸收的药物

普鲁本辛、灭吐灵、制酸剂

C. 增加甲氟咪胍代谢的药物

甲氧乙心安(美多心安)、苯巴比妥

[《药局》35(8):122,1984(日文)]

朱宝华摘 罗顺德校

硝苯吡啶对慢性阻塞性肺病患者的治疗作用

对正常男子4名,支气管哮喘12例,慢性肺气肿6例和有并发症者7例(因并发哮喘、慢性支气管哮喘和肺气肿而不能进行分类者),根据美国胸科学会的标准,以临床症状、肺功能、X线照片及选择性肺泡一支气管造影为基础进行诊断。全部受试者在观察期间及观察前12小时内禁用任何支气管扩张剂。